

Virosis respiratorias leves

Resfrío común, faringitis, laringitis y bronquitis aguda · Cuándo NO dar antibiótico · Los criterios que sí justifican tratarlo

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección IV (Infectología ambulatoria)

Glosario de siglas: IRA: infección respiratoria aguda · SGA: *Streptococcus* del grupo A (*S. pyogenes*) · VRS: virus respiratorio sincicial · PCR: proteína C reactiva · PCT: procalcitonina · TDR: test de detección rápida de antígeno · EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica · PROA: programa de optimización del uso de antimicrobianos · MINSAL: Ministerio de Salud de Chile.

Alcance y fuentes. Basado en las guías IDSA de faringitis estreptocócica (2012) y de sinusitis bacteriana aguda (2012), las recomendaciones del American College of Physicians y de los CDC sobre uso apropiado de antibióticos en infecciones respiratorias altas, y las guías de bronquitis aguda. **La prescripción antibiótica en este grupo de cuadros es el principal objetivo de los programas de uso racional en atención ambulatoria.**

Índice

1. Por qué este tema importa tanto
2. Resfrío común
3. Faringoamigdalitis: la decisión clave
4. Criterios de Centor y uso del test rápido
5. Tratamiento de la faringitis estreptocócica
6. Faringitis que no son estreptocócicas y no hay que perder
7. Laringitis y traqueítis
8. Bronquitis aguda
9. Rinosinusitis aguda
10. Influenza y COVID-19 en el ambulatorio
11. Señales de alarma: cuándo derivar o estudiar
12. Cómo comunicar la decisión de no dar antibiótico
13. Errores frecuentes
14. Perlas de alto rendimiento
15. Bibliografía esencial

1. Por qué este tema importa tanto

Las infecciones respiratorias altas son **el motivo de consulta ambulatoria más frecuente** y, a la vez, **la principal fuente de prescripción antibiótica innecesaria** en la comunidad. Los estudios en atención primaria muestran de forma consistente que **más de la mitad de los antibióticos prescritos en este contexto no tienen indicación**.

Las consecuencias son concretas: resistencia antimicrobiana comunitaria, reacciones adversas —incluidas las cutáneas graves—, infección por *C. difficile*, y la creación de una expectativa que hace más difícil la consulta siguiente.

La regla que resume el tema La inmensa mayoría de estos cuadros son virales, autolimitados y no requieren antibiótico. El trabajo clínico consiste en reconocer la minoría que sí lo necesita —y en explicar bien la decisión al paciente.

2. Resfrío común

- **Agentes:** rinovirus (el más frecuente), coronavirus estacionales, VRS, parainfluenza, metapneumovirus, adenovirus.
- **Clínica:** congestión y descarga nasal, odinofagia leve, estornudos, tos, malestar. **La fiebre es ausente o baja en el adulto.**
- **Curso:** los síntomas alcanzan su máximo entre el día 2 y 3 y **duran 7-10 días; la tos puede persistir 2-3 semanas** y es la causa más frecuente de reconsulta.

- **La secreción nasal purulenta o de color verde-amarillo es parte de la evolución natural del resfrío y NO indica infección bacteriana ni justifica antibiótico.** Es probablemente el malentendido más extendido y el que más prescripciones innecesarias genera.
- **Tratamiento: sintomático.** Analgésicos y antipiréticos, hidratación, solución salina nasal. Descongestionantes tópicos por no más de 3-5 días (riesgo de rinitis medicamentosa). Antihistamínicos de primera generación con descongestionante tienen efecto modesto. **No hay evidencia sólida** para vitamina C, zinc o equinácea como tratamiento establecido.
- **No usar antibióticos**, cualquiera sea el color de la secreción o la duración dentro de los 10 días.

3. Faringoamigdalitis: la decisión clave

El 80-90 % de las faringitis del adulto son virales. Sólo el 5-15 % en el adulto (y 20-30 % en el niño) son por *Streptococcus pyogenes*.

El objetivo del tratamiento antibiótico en la faringitis estreptocócica es doble: acortar los síntomas (efecto modesto, 1-2 días) y sobre todo **prevenir la fiebre reumática aguda**, además de reducir las complicaciones supurativas y la transmisión.

A favor de etiología viral	A favor de etiología estreptocócica
Tos, coriza, disfonía, conjuntivitis	Ausencia de tos
Úlceras orales, diarrea	Exudado amigdalino
Curso gradual	Inicio brusco
	Adenopatías cervicales anteriores dolorosas
	Fiebre > 38 °C
	Petequias en paladar, exantema escarlatiniforme, lengua aframbuesada
	Edad 3-14 años; contacto con caso confirmado

4. Criterios de Centor y uso del test rápido

Criterios de Centor modificados (McIsaac) — 1 punto cada uno:

- Ausencia de tos - Exudado o aumento de volumen amigdalino - Adenopatías cervicales anteriores dolorosas - Fiebre > 38 °C - Edad: 3-14 años (+1), 15-44 años (0), >= 45 años (-1)

Puntaje	Probabilidad de SGA	Conducta recomendada
<= 0-1	1-10 %	No estudiar ni tratar: manejo sintomático
2-3	11-35 %	Test rápido de antígeno (o cultivo faríngeo): tratar sólo si es positivo
>= 4	50-60 %	Test rápido; tratar si es positivo. Algunas guías aceptan tratamiento empírico, pero la recomendación IDSA es confirmar

Sobre las pruebas:

- **Test rápido de detección de antígeno: especificidad alta (> 95 %)**, sensibilidad 70-90 %. Un **positivo confirma**; un negativo en el adulto, con la baja prevalencia y el bajo riesgo de fiebre reumática, **no requiere confirmación con cultivo** (a diferencia del niño, en quien la IDSA recomienda cultivo de respaldo).
- **Cultivo faríngeo**: es el estándar; demora 24-48 horas.
- **Biología molecular**: mayor sensibilidad, disponible en algunos centros.
- **NO se debe estudiar** a pacientes con criterios de Centor 0-1 ni a portadores asintomáticos: el **estado de portador crónico** (5-20 % de la población, mayor en niños) genera pruebas positivas sin enfermedad, y su tratamiento es innecesario.
- **ASO y anti-DNasa B no sirven** para diagnosticar una faringitis aguda: son marcadores de infección pasada.

5. Tratamiento de la faringitis estreptocócica

Fármaco	Dosis y duración
Penicilina V	500 mg VO cada 12 h por 10 días

Fármaco	Dosis y duración
Amoxicilina	1 g/día VO (o 500 mg cada 12 h) por 10 días — mejor sabor y adherencia
Penicilina G benzatina	1.200.000 UI IM dosis única — de elección si hay dudas de adherencia
Alergia no anafiláctica	Cefalexina o cefadroxilo por 10 días
Alergia grave (IgE)	Azitromicina 500 mg/día por 5 días, claritromicina, o clindamicina — vigilando la resistencia local a macrólidos

Puntos clave:

- Los 10 días son para erradicar el estreptococo y prevenir la fiebre reumática, no para resolver los síntomas, que mejoran en 3-4 días. Acortar el tratamiento pierde ese objetivo.
- *S. pyogenes* es universalmente sensible a penicilina: nunca hay que preocuparse de resistencia a betalactámicos.
- El tratamiento previene la fiebre reumática incluso iniciado hasta 9 días después del inicio de los síntomas — de modo que esperar el resultado del cultivo es seguro.
- El antibiótico NO previene la glomerulonefritis postestreptocócica.
- Corticoides: una dosis única de dexametasona reduce modestamente el dolor en la faringitis grave; **no son parte del tratamiento estándar** y no sustituyen al antibiótico cuando está indicado.
- No se requieren cultivos de control ni tratamiento de contactos asintomáticos, salvo en situaciones especiales (brotes, antecedente familiar de fiebre reumática).

6. Faringitis que no son estreptocócicas y no hay que perder

Entidad	Claves
Mononucleosis infecciosa (VEB)	Adolescente o adulto joven, fatiga marcada, adenopatías cervicales posteriores, esplenomegalia, linfocitosis atípica. El exantema tras ampicilina o amoxicilina es característico
VIH agudo (síndrome retroviral agudo)	Faringitis con úlceras mucosas , exantema, fiebre, adenopatías, mialgias. Hay que preguntar por conductas de riesgo y solicitar carga viral , porque la serología puede ser aún negativa
Gonorrea faríngea	Habitualmente asintomática; considerar en el contexto de conductas sexuales de riesgo
Sífilis secundaria	Faringitis con exantema palmoplantar, adenopatías generalizadas
Absceso periamigdalino	Trismus , voz "de papa caliente", desviación de la úvula, asimetría. Requiere drenaje
Absceso retrofaríngeo / angina de Ludwig	Odinofagia intensa, compromiso del piso de boca, estridor. Urgencia
Síndrome de Lemierre	Faringitis seguida días después de fiebre alta, dolor laterocervical y nódulos pulmonares cavitados por <i>Fusobacterium necrophorum</i>
Epiglottitis	Odinofagia desproporcionada al examen, estridor, babeo, posición en trípode. Urgencia de vía aérea
Difteria	Membrana grisácea adherente que sangra al desprenderse. Considerar en no vacunados

Las banderas rojas de una faringitis Trismus · estridor o dificultad respiratoria · babeo · asimetría faríngea · dolor cervical unilateral o empastamiento · odinofagia desproporcionada al examen · deterioro tras varios días. Cualquiera de ellas obliga a evaluación urgente, imagen y, con frecuencia, drenaje.

7. Laringitis y traqueítis

- **Casi siempre virales.** Disfonía, tos seca, molestia laríngea.
- **Duración habitual 1-2 semanas;** la disfonía puede persistir más.
- **Tratamiento sintomático:** reposo vocal, hidratación, humidificación. **Los antibióticos no aportan beneficio** y no deben indicarse.

- **Derivar a otorrinolaringología** si la disfonía persiste **más de 3 semanas**, especialmente en fumadores, por el riesgo de neoplasia laríngea.

8. Bronquitis aguda

Es, junto con el resfriado, la entidad donde más se prescriben antibióticos sin indicación.

- **Definición:** tos aguda de menos de 3 semanas, con o sin expectoración, **sin neumonía**, en un paciente **sin enfermedad pulmonar crónica**.
- **Más del 90 % son virales.** Los agentes bacterianos posibles —*Mycoplasma*, *Chlamydia*, *Bordetella pertussis*— explican una minoría.
- **La tos dura en promedio 2-3 semanas**, y ese dato debe anticiparse al paciente: la persistencia de la tos **no significa fracaso ni indicación de antibiótico**.
- **La expectoración purulenta refleja descamación epitelial e inflamación, no infección bacteriana.**
- **Los antibióticos no aportan beneficio clínicamente relevante:** los metaanálisis muestran una reducción de la tos de menos de un día, a costa de efectos adversos significativos.
- **Descartar neumonía:** la ausencia de taquicardia, taquipnea, fiebre y de hallazgos focales en el examen pulmonar hace muy improbable la neumonía y **no requiere radiografía** en el paciente sin comorbilidad.
- **Considerar tos ferina** ante tos > 2 semanas con paroxismos, estridor inspiratorio o vómitos postusivos: se confirma con **PCR de hisopado nasofaríngeo** y se trata con **azitromicina**, fundamentalmente **para reducir la transmisión** (el efecto sobre los síntomas es escaso si se inicia tarde). **Es de notificación obligatoria y requiere estudio y profilaxis de contactos**, especialmente de lactantes y embarazadas.
- **Tratamiento sintomático:** los broncodilatadores tienen un lugar sólo si hay sibilancias o hiperreactividad bronquial. Los antitusivos tienen eficacia limitada.
- **Excepción importante:** en la **exacerbación de EPOC**, los criterios de Anthonisen (aumento de la disnea, del volumen y de la purulencia del esputo) sí orientan a beneficio del antibiótico en exacerbaciones moderadas a graves.

9. Rinosinusitis aguda

- **Más del 98 % de las rinosinusitis agudas son virales.**
- **Cuándo sospechar sobreinfección bacteriana** (criterios IDSA): cualquiera de los tres patrones:

1. **Síntomas persistentes** ≥ 10 días sin mejoría. 2. **Síntomas graves desde el inicio:** fiebre ≥ 39 °C con descarga purulenta o dolor facial, por al menos 3-4 días consecutivos. 3. **"Doble empeoramiento":** mejoría inicial de un cuadro viral típico seguida de un nuevo deterioro con fiebre, cefalea o aumento de la descarga.

- **Agentes:** *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *M. catarrhalis*.
- **Tratamiento cuando está indicado: amoxicilina-ácido clavulánico** por 5-7 días en el adulto (la IDSA prefiere amoxicilina-clavulánico sobre amoxicilina sola por la prevalencia de productores de betalactamasa). Alérgicos: doxiciclina; o quinolona respiratoria como alternativa, reservada.
- **Los macrólidos y el cotrimoxazol no se recomiendan** por la resistencia de neumococo.
- **Tratamiento sintomático:** corticoides nasales tópicos (con beneficio modesto), lavados con solución salina, analgésicos.
- **Banderas rojas que obligan a imagen y derivación urgente:** edema o eritema periorbitario, proptosis, alteración de la movilidad ocular o de la visión, cefalea intensa, signos meníngeos, compromiso de conciencia o déficit focal (celulitis orbitaria, trombosis del seno cavernoso, absceso intracraneal).

10. Influenza y COVID-19 en el ambulatorio

- **Influenza:** iniciar **oseltamivir** en pacientes de **grupo de riesgo** (≥ 65 años, embarazo, comorbilidad crónica, inmunosupresión, obesidad mórbida) o con enfermedad progresiva, idealmente dentro de las 48 horas. **No esperar la confirmación.** En el adulto sano sin factores de riesgo, es opcional dentro de las 48 h. Ver el documento de virosis respiratorias graves.
- **COVID-19:** antiviral precoz (dentro de los 5 días) en pacientes con factores de riesgo de progresión, revisando exhaustivamente las interacciones. **Los corticoides no se usan en el paciente ambulatorio sin requerimiento de oxígeno.**
- **En ambos casos,** indicar aislamiento según la normativa vigente, y vacunación como prevención.

11. Señales de alarma: cuándo derivar o estudiar

- **Disnea, taquipnea (> 24/min), taquicardia (> 100/min), saturación < 94 %.** - **Hipotensión, compromiso de conciencia, deshidratación.** - **Fiebre > 5 días o reaparición de la fiebre** tras mejorar. - **Dolor pleurítico, hemoptisis, crepitaciones focales** -> radiografía de tórax. - **Tos > 3 semanas** -> estudio de tos crónica; en Chile, **considerar tuberculosis** y solicitar baciloscopías, sobre todo con baja de peso, sudoración nocturna o factores de riesgo. - **Disfonía > 3 semanas** -> otorrinolaringología. - **Trismus, estridor, babeo, asimetría faríngea o cervical** -> urgencia. - **Signos orbitarios o neurológicos** en sinusitis -> urgencia. - **Inmunosupresión, embarazo, comorbilidad descompensada** -> umbral más bajo para estudiar y tratar.

12. Cómo comunicar la decisión de no dar antibiótico

La calidad de la comunicación es la variable que más determina si el paciente acepta el manejo sintomático, y es una habilidad clínica concreta:

- **Nombrar el diagnóstico:** decir "esto es una bronquitis viral" en lugar de "no es nada". - **Anticipar el curso natural:** "la tos va a durar dos a tres semanas y eso es normal". - **Explicar por qué el antibiótico no ayuda** y qué daño puede hacer (diarrea, alergia, resistencia). - **Ofrecer un plan sintomático concreto**, no una negativa. - **Dar criterios de reconsulta explícitos** ("vuelva si aparece fiebre alta después del quinto día, dificultad para respirar o dolor en el pecho"). - **Considerar la "receta diferida":** entregar una receta con indicación de usarla sólo si no hay mejoría en un plazo definido. **Reduce el consumo de antibióticos** manteniendo la satisfacción del paciente.

13. Errores frecuentes

- **Tratar con antibiótico una secreción nasal purulenta:** es parte del curso viral normal. - **Tratar toda faringitis con exudado** sin aplicar los criterios de Centor ni el test rápido. - **Tratar bronquitis aguda** con antibiótico. - **Acortar a 5 días el tratamiento de la faringitis estreptocócica** (deben ser 10 con penicilina o amoxicilina). - **Pedir ASO** para diagnosticar una faringitis aguda. - **Estudiar y tratar portadores asintomáticos** de *S. pyogenes*. - **No pensar en VIH agudo** ante una faringitis con úlceras y exantema. - **No reconocer un absceso periamigdalino** ante trismus y asimetría. - **No considerar tos ferina** ante tos de más de dos semanas con paroxismos. - **No considerar tuberculosis** ante tos de más de tres semanas. - **Usar macrólidos o cotrimoxazol** en sinusitis bacteriana. - **No anticipar la duración de la tos**, lo que genera reconsulta y presión por antibiótico.

14. Perlas de alto rendimiento

- **La secreción purulenta no significa infección bacteriana.**
- **La tos de una bronquitis aguda dura 2-3 semanas:** anticiparlo evita antibióticos innecesarios.
- **Centor: ausencia de tos, exudado, adenopatías dolorosas, fiebre y edad.** Con 0-1 punto, ni estudiar ni tratar.
- **El test rápido tiene alta especificidad:** un positivo confirma. En el adulto, un negativo no requiere cultivo de respaldo.
- **Faringitis estreptocócica: 10 días** de penicilina o amoxicilina, o **penicilina benzatina en dosis única.**
- **El antibiótico previene la fiebre reumática hasta 9 días después del inicio**, pero **no previene la glomerulonefritis.**
- ***S. pyogenes* es siempre sensible a penicilina.**
- **Exantema tras amoxicilina en una faringitis = pensar en mononucleosis.**
- **Faringitis con úlceras mucosas y exantema en un adulto joven = descartar VIH agudo con carga viral.**
- **Sinusitis bacteriana: >= 10 días sin mejoría, síntomas graves >= 3-4 días, o doble empeoramiento.** Tratamiento: amoxicilina-clavulánico 5-7 días.
- **Tos > 3 semanas en Chile: pedir baciloscopías.**
- **La receta diferida reduce el consumo de antibióticos sin perder satisfacción del paciente.**

15. Bibliografía esencial

- Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the IDSA. *Clin Infect Dis.* 2012;55:e86-e102.

- Chow AW, Benninger MS, Brook I, et al. IDSA clinical practice guideline for acute bacterial rhinosinusitis in children and adults. *Clin Infect Dis*. 2012;54:e72-e112.
- Harris AM, Hicks LA, Qaseem A. Appropriate antibiotic use for acute respiratory tract infection in adults: advice for high-value care from the ACP and the CDC. *Ann Intern Med*. 2016;164:425-34.
- Smith SM, Fahey T, Smucny J, Becker LA. Antibiotics for acute bronchitis. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017;6:CD000245.
- Spurling GK, Del Mar CB, Dooley L, et al. Delayed antibiotic prescriptions for respiratory infections. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017;9:CD004417.
- McIsaac WJ, Kellner JD, Aufricht P, et al. Empirical validation of guidelines for the management of pharyngitis in children and adults. *JAMA*. 2004;291:1587-95.
- Ebell MH, Smith MA, Barry HC, et al. Does this patient have strep throat? *JAMA*. 2000;284:2912-8.